

高齡心衰竭照護最佳化

Strategies for Optimizing Heart Failure Care in the Older Adult



AHA 2026 scientific statement | 台灣醫師閱讀版

整理重點：GDMT、裝置治療、共病與衰弱、shared decision-making、緩和醫療與照護落地

阿婷醫師的讀書筆記

阿婷醫師的讀書筆記

高齡心衰竭是最大照護負擔之一

- 心衰竭盛行率隨年齡上升，住院與再住院主要集中在 65 歲以上族群。
- 高齡病人常同時有衰弱、認知退化、腎功能下降、營養不良與社會孤立。
- 臨床目標不只降低死亡率，也包含維持功能、減少住院、提升生活品質。

實務重點：不要只問「可不可以用 GDMT」，更要問「如何讓這位病人能安全且持續地用」。

GDMT：高齡不是自動排除條件

- HFrEF 四大藥物：ARNI 或 ACEi/ARB、實證 beta blocker、MRA、SGLT2 inhibitor。
- 重要試驗次分析顯示，ARNI、SGLT2 inhibitor、MRA 與 beta blocker 的治療效果在年齡分層大致一致。
- HFmrEF/HFpEF：SGLT2 inhibitor、MRA、利尿劑與特定情境下的 RAAS 相關治療，仍需依表現型與耐受性選擇。

高齡病人事件率高，絕對效益可能很重要；但副作用監測要更細。

真正的問題：有效治療常被低度使用

- 登錄資料顯示，年齡越高，eBB、MRA、ARNI 或 RAASi 使用與劑量最佳化越少。
- 女性高齡病人可能面臨更明顯的 GDMT 使用落差。
- 常見原因：低血壓、腎功能、共病、多重用藥、費用、追蹤不易與臨床慣性。

處方策略：低劑量啟動、早期追蹤、主動處理副作用，而不是直接放棄治療。

CIED：ICD 與 CRT 要分開思考

- ICD：初級預防在高齡與複雜共病族群的淨效益較不確定，需考量有意義存活超過 1 年、猝死風險與病人偏好。
- CRT：可改善症狀、生活品質、住院與存活；不應只因年齡而排除。
- 裝置決策要納入併發症、回診負擔、電擊經驗、末期照護與去活化討論。

問法轉換：不是「幾歲還能裝」，而是「裝置對他的疾病歷程與在意的結果有沒有幫助」。

四大 domain：把心衰竭照護拉回整個人

Medical

營養、鐵缺乏、腎功能、多重用藥、藥物交互作用

Mind and emotion

認知功能、憂鬱、服藥理解、家屬或照顧者協助

Physical

衰弱、跌倒、姿勢性低血壓、肌力、活動能力

Social

交通、費用、社會孤立、健康識能、視訊照護可近性

多重用藥與營養：先找可修正因子

- 每次調整 GDMT 前後，重新核對藥物、血壓、體重、eGFR、鉀離子與症狀。
- 避免同時忽略低營養、鐵缺乏、利尿劑過量、NSAID、alpha blocker 等影響耐受性的因素。
- deprescribing 不是少治療，而是移除低價值或高風險藥物，讓高價值治療留下來。

高齡處方的核心：不是單純加藥或減藥，而是提高整體 treatment fit。

GDMT 卡住時：用多層次障礙拆解

病人層級

症狀負擔、跌倒擔心、健康識能、藥費、交通、照顧者缺乏

醫療團隊層級

臨床慣性、副作用擔心、跨科訊息不一致、追蹤間隔太長

系統層級

給付限制、門診時間不足、藥師與護理資源不足、轉銜照護斷裂

把「病人不配合」改寫成「哪一層障礙還沒被解決」。

Shared decision-making：目標會變，必須反覆確認

- 先釐清 what matters most：壽命、功能、症狀、居家生活、避免住院、避免侵入性治療。
- 討論治療效益時，也要說明負擔：抽血、回診、輸注、裝置併發症、住院天數、照顧者壓力。
- ACP 不是只在末期才談；晚期治療、LVAD、ICD 去活化與緩和醫療都需要預先對話。

SDM 不是把決定丟給病人，而是用醫療證據幫病人做符合價值的選擇。

能提高 GDMT uptake 的做法

- 費用協助或給付改善：降低藥費可提升可近性，特別是固定收入的高齡族群。
- 電子決策支持、病人啟動工具與藥物 titration protocol：減少臨床慣性。
- 自我照護教育、遠距監測、出院轉銜照護、跨專業團隊：改善追蹤與持續性。

有些 intervention 改善處方率，有些改善照護銜接；不要期待單一工具解決所有問題。

緩和醫療：不是放棄治療，是減少不必要痛苦

- 高齡晚期心衰竭常見 refractory symptoms、反覆住院、GDMT 無法耐受與照顧負擔升高。
- 緩和醫療可協助症狀控制、目標釐清、家庭溝通、ACP 與治療負擔評估。
- hospice 與 palliative care 不等同；早期轉介可與疾病治療並行。

對 refractory HF：早期心衰竭專科與緩和醫療共同照護，通常比最後一刻才會診更有價值。

門診可用的高齡 HF 五步驟



台灣臨床情境的落地提醒

- 把「藥物加不上去」記錄成具體原因：血壓、腎功能、鉀離子、症狀、費用、回診或照顧支持。
- 出院後 7 到 14 天內安排追蹤，優先檢視利尿劑、腎功能、電解質與四大藥物缺口。
- 善用護理師、藥師、營養師、復健與居家照護資源，避免心衰竭治療只剩單一醫師處方。

每次門診留下下一步：要加哪一類藥、何時抽血、何時回診、誰負責追蹤。

醫師版重點整理

- 高齡不是 GDMT 或 CRT 的自動排除條件，但需要更精細的安全監測與目標討論。
- ICD 初級預防在高齡複雜共病中要更重視淨效益、預期存活與病人偏好。
- 高齡心衰竭照護要同時處理 medical、mind、physical、social domains。
- SDM、ACP 與緩和醫療應早期、反覆、以病人價值為核心。

最佳化不是追求每個人都滿劑量，而是讓每位病人得到最符合證據與目標的照護組合。

文獻來源與延伸閱讀

1. Lewsey SC, Martyn T, Blumer V, et al. Strategies for Optimizing Heart Failure Care in the Older Adult: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2026;153:e00-e00.
2. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001437
3. AHA Journals: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001437>
4. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001063

臨床使用提醒：本投影片為文獻閱讀整理，不能取代完整原文、藥品仿單、院內規範或個別病人評估。